

Université Salah Bounider Constantine 3
Centre hospitalo-universitaire Benbadis Constantine
Cours de 4^{ème} année de médecine
Module onco-hématologie

Principes diagnostiques et bilan pré thérapeutique en oncologie

Le : 11/11/2025

Dr. BENSEHAMDI. A
Maître assistante
Oncologie médicale

Plan :

I/ Introduction

1. Définitions
2. objectifs

II/ Diagnostic positif

1. Circonstances de découverte
2. Diagnostic clinique
3. Diagnostic para clinique
 - A/Diagnostic biologique
 - B/Diagnostic radiologique
 - C/Diagnostic endoscopique
 - D/ Diagnostic histologique

III/ Diagnostic différentiel

IV/ Diagnostic pré thérapeutique et pronostique

1. Bilan d'extension:
2. Bilan général et fonctionnel

V/ Pronostic

VI/ Conclusion

I/ Introduction :

1. Définitions:

- Le diagnostic de cancer est établi devant un symptôme d'alerte, cette définition s'oppose à celle du dépistage ; où on recherche à découvrir une tumeur en absence de symptôme (surtout sujet à risque).
- démarche aboutissant à l'affirmation d'un cancer chez un patient consultant pour un symptôme.

2. Objectifs :

- Arriver le plus rapidement possible au diagnostic.
- Connaissance histologique précise.
- Faire le bilan complet de la pathologie cancéreuse.
- Définir le stade du cancer que l'on va devoir traiter.
- Mettre en route un projet thérapeutique concerté

II/ Diagnostic positif :

1. Circonstances de découverte :

- **Symptôme révélateur** +++ : douleur, hépatomégalie, lésions nodulaire, masse palpable.
- **Syndrome inflammatoire** : (fièvre persistante' vs augmentée)
- **Signes généraux** : (A, A, A)
- **Métastase révélatrice** : ganglionnaires, osseuses, pulmonaires, hépatiques, cérébrales
- **Syndrome paranéoplasique** : ensemble de modification biologique et anatomoclinique non cancéreuse associée au développement d'un cancer

2. Diagnostic clinique :

a/Anamnèse (interrogatoire) :

- Histoire de la symptomatologie : début des symptômes, caractère, évolution...
- Antécédents personnels et familiaux.

b/Examen clinique :

(Inspection, palpation, percussion, touchers pelviens)

- examen de la zone d'appel.

- Les territoires ganglionnaires régionaux +++(ADP satellites)
- Les éventuelles métastases à distance
- noter (mobilité ou fixité, aspect), mesurer, photographier...

3. Diagnostic para clinique :

A/Diagnostic biologique :

- **Examens utiles pour le Diagnostic positif: / Marqueurs Tumoraux:**

- Ag onco-fœtaux (ACE, AFP)
- Ag spécifiques d'organes (CA 125, CA 15.3, CA 19.9, SCC, PSA)
- Enzymes (PAP, NSE)
- Hormones et métabolites (HCG et β HCG, Calcitonine, Thyroglobuline)

- **Examens utiles pour le bilan d'extension:**

- Bilan phosphocalcique
- Bilan hépatique
- Bilan hématologique
- LDH
- Marqueurs Tmx: AFP, HCG =>> Tm germinales, AFP =>> CHC, PSA, =>> Kc prostate, TG =>> Kc différencié de la thyroïde

B/ Diagnostic radiologique :

1. Radiologie conventionnelle :

- garde une place malgré les progrès des techniques d'imagerie.
- Radio osseuses : tumeur primitive ou secondaire, myélome multiple
- Mammographie : ex de 1ère intention pour le sein.
- Télé thorax : kC Bronchiques médiastinales, thymiques

2. Echographie et écho-endoscopie :

- Examen peu coûteux, simple, non invasif
- A demander en 1ère intention pour une masse abdomino-pelvienne (VB, foie ,rein, pancréas, et même péritoine....)
- Echo rectale, vaginale

- Permet Biopsies ou cyto écho guidées.

3. TDM : Examen de choix

- Permet de rechercher des tumeurs dans tous les territoires et bilan extension :
- (Cérébral, rachidienne, thoracique, abdominal, pelvienne...)

4. IRM :

- Meilleur contraste tissus mous avant l'injection de produit iodé.
- **Ci** : présence d'1 stimulateur cardiaque ou de clips chirurgicaux

5. La tomographie par émission de positons: Le PET scan :

- méthode d'imagerie médicale obtenue par injection d'un traceur faiblement radioactif par voie intraveineuse.
- Le marqueur est le plus souvent le **fluor 18** (^{18}F) incorporé dans une molécule de **glucose** formant le ^{18}F -fluorodésoxyglucose (^{18}F -FDG) .
- permet de mesurer l'activité métabolique ou moléculaire d'un organe grâce aux émissions produites par les positons issus du produit radioactif.

6. Scintigraphie osseuse au technetium 99m:

Repose sur la fixation dans les structures osseuses de molécules phosphatées marquées au **technétium-99m**.

7. Scintigraphie thyroïdienne:

Elle fournit des informations morphologiques et fonctionnelles de la glande thyroïde.

8. Imagerie interventionnelle:

- C'est un examen qui permet d'apporter la preuve histologique cancers.
- Le guidage et le suivi des aiguilles s'effectuent par échographie ou par TDM.

C/Diagnostic endoscopique :

- Pour organes creux: Pan endoscopie, fibroscopie, coloscopie, cystoscopie
- Cœlioscopie ou laparoscopie visé diagnostic et thérapeutique
- Avantage: visualisation directe des lésions prélèvement biopsiques

D/Diagnostic histologique :

1. La cytologie (étalement) :

- Par exfoliation (Col, Cavité buccale, lavage broncho alvéolaire)

- Liquidienne : par ponction d'un épanchement (Pleurésie ascite, LCR)
- ponction d'une masse
- Souvent moins performante (faux négatifs) : **une cytologie n'a de valeur que+**

2. La biopsie +++ (fragment) :

- Chirurgicale -Endoscopique (ORL, Branche, estomac, Colon)
- Radiologique (Sein, Foie, Rein, Prostate, Poumon, Gg Lombo-aortique)

3- Immunohistochimie :

- technique d'histologie visant à localiser une protéine donnée dans un tissu.
- Le principe repose sur la reconnaissance d'un antigène par un anticorps spécifique et la révélation de ce complexe antigène-anticorps par une réaction chimique grâce à une enzyme et son substrat.

4-Le compte rendu anatomo-pathologique +++ :

- **Aspect macroscopique**

1. Formes classiques:

a. au niveau des revêtements: (malpighien cutané, malpighien des muqueuses, cubocylindriques et excréto-urinaire):

- Cancer végétant ou exophytique;
- Cancer ulcéré;
- Cancer infiltrant;
- Cancer ulcéro-végétant ou ulcéro-infiltrant.

b. dans les viscères et organes pleins:

- Cancer nodulaire;
- Cancer massif;
- Cancer kystique;
- Cancer cavitaire;
- Cancer encéphaloïde;
- Cancer squirrheux.

- **Aspect microscopique +++ :**

- variété histologique : ADK , carcinome , lymphome , sarcome ...

- infiltration ou non au-delà de la membrane basale

- Différenciation -Grade -Limites de résection

- Envahissement ganglionnaire +++, Ruptures capsulaire

Elle permet de classer les cancers en fonction du tissu dont ils sont issus:

1. Tumeurs solides:

a. carcinome: Leur point de départ est un épithélium

* carcinomes malpigiens ou épidermoïdes: ils ressemblent à l'épithélium de malpighi

* adénocarcinome: leur point de départ est un épithélium glandulaire

* carcinome excréto-urinaires ou transitionnels: (paramalpigiens ou urothéliaux) elles se trouvent seulement au niveau des voies urinaires excrétrices

b. sarcomes:

Ce sont des tumeurs de structure mésenchymateuse le plus souvent unitissulaire;

Selon leur tissu d'origine, on distingue les fibrosarcomes, liposarcomes, ostéosarcome...

c. tumeurs à structure neuroectoblastique

- Tumeurs neuroectoblastique proprement dites:ce sont des Tm de la névralgie(gliome) et du revêtement des cavités cérébrospinales SNC

- Tumeurs méséctodermiques:

- Tumeurs des méninges(méningiome)
- Ganglions nerveux sympathiques et parasympathique (ganglioneurome, chémodectome)
- Gaines de schwann (schwannome)
- Système mélanogénique (mélanome malin)

d. tumeurs de structure embryonnaire, uni ou pluritissulaires:

- Plus ou moins matures: dysembryome
- Moins matures (Tm indifférenciées): neuroblastome, néphroblastome(surtout chez l'enfant), choriocarcinome d'origine placentaire, testiculaire, ou rarement ovarienne.
- Matures (très indifférenciées): forment des tératomes

e. Tumeurs de structure composite uni ou pluritissulaire:

- Elles sont formées de structures diverses associées: ex carcinome mixte épidermoïde et glandulaire

2. Tumeurs hématopoïétiques :

a. lymphome malin:

- Non hodgkinien et la maladie de hodgkin

b. leucémies: leur point de départ se situe au niveau des cellules hématopoïétiques d'origine médullaire

TRIADE:

Clinique – Radiologie – Histologie

=>>>

Diagnostic de certitude

III/ Diagnostic différentiel :

- **Pathologies infectieuses:** virale, parasitaire, bactérienne
- **Pathologies bénignes :** lipome...
- **Pathologies malignes:** du même organe, en général ou métastase des autres cancers dans l'organe

IV/ Diagnostic pré thérapeutique et pronostique :

1. Bilan d'extension:

Clinique :

- Extension locale : diamètre de la tumeur
- Extension régionale : extension aux organes voisinage, gg régionaux.
- A distance : HPM, SPM, épanchement pleural.

Para clinique :

- Radiologique : échographie, scanner, IRM
- Radio isotopique : scintigraphie, PET scan

TNM, stadification :

Classement TNM:

- **T:** tumeur, **/N:** nodes : ganglion, **/M:** métastases
- Le système TNM est une description abrégée de l'extension d'un cancer , il comporte deux classifications:

* une classification clinique pré-thérapeutique, appelée TNM ou cTNM (c pour clinical)

*Une classification histo-pathologique postopératoire , appelée pTNM (p pour pathological)

- le pTNM est plus pertinent que le cTNM pour l'évaluation du pronostic .

Stades:

- **Stade I:** T1 N0 M0(locaux) contrôle local aisé ,potentialité de guérison dans 70% a 90% des cas .
- **Stade II:** T2 et/ou N1 M0(extension loco-régionale avec risque de métastases occultes) contrôle loco régionale possible , potentialité de guérison voisine de 50% des cas .
- **Stade III:** T3 et/ou N2 M0 (extension aux organes de voisinage et forte probabilité de métastases occultes) contrôle loco-régionale aléatoire , potentialité de guérison de l'ordre de 20% des cas .
- **Stade IV:** T4 et /ou M+, contrôle local impossible , guérison exceptinnelle.

2. Bilan général et fonctionnel : Bilan du patient :

- Evaluation des co-morbidités
- Etat général selon l'échelle OMS
- Etat cardiovasculaire: ECG; échocardiographie.
- Etat respiratoire: EFR.
- Etat rénal
- Etat neurologique
- Etat psychologique
- Etat nutritionnel

V/ Pronostic :

- A évaluer durant toutes les phases de la maladie.
- Dépend de 3 facteurs : Tumeur (siège, classification, histologie), patient (âge, tares, symptômes, EG) et Thérapeutique (qualité de la chirurgie).

VI/ Conclusion :

- Le diagnostic des cancers a bénéficié des progrès de l'imagerie moderne, notamment pour ce qui est du bilan d'extension préalable à tous traitements.
- Le diagnostic individuel précoce a une influence majeure sur le pronostic global améliorant les possibilités de contrôle local et diminuant le risque de métastase à distance.